Rx

ABRYSVO®

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT:
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tiêm bắp (tb).

1. TÊN THUỐC

ABRYSVO®

2. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Thành phần hoạt chất: Sau khi hoàn nguyên, một liều (0,5 mL) chứa:

Kháng nguyên F ổn định tiền dung hợp của RSV phân nhóm A[1,2]	60 microgram
Kháng nguyên F ổn định tiền dung hợp của RSV phân nhóm B[1,2]	60 microgram

(các kháng nguyên RSV)
[1]glycoprotein F ổn định ở dạng tiền dung hợp
[2]được tạo ra trong các tế bào buồng trứng chuột hamster Trung Quốc bằng công nghệ ADN tái tổ hợp.

Thành phần tá dược:

Thuốc bột
Trometamol
Trometamol hydrochloride
Sucrose
Mannitol
Polysorbat 80
Natri clorid

Dung môi
Nước pha tiêm

3. DẠNG BÀO CHẾ

Bột và dung môi pha dung dịch tiêm.

Bột màu trắng.
Dung môi là chất lỏng trong, không màu.

4. CHỈ ĐỊNH

Abrysvo được chỉ định để:

- Bảo vệ thụ động chống lại bệnh đường hô hấp dưới do vi rút hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus - RSV) gây ra ở trẻ nhũ nhi từ khi sinh ra đến 6 tháng tuổi bằng cách tiêm chủng cho người mẹ trong thời kỳ mang thai. Xem các mục 5 và 13.

- Tiêm chủng chủ động cho những người từ 60 tuổi trở lên để phòng ngừa bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra.

Việc sử dụng vắc xin này phải tuân theo các khuyến nghị chính thức.

5. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Liều dùng

Phụ nữ mang thai
Tiêm một liều đơn 0,5 mL trong khoảng thời gian từ tuần 24 đến tuần 36 của thai kỳ (xem các mục 7 và 13).

Những người từ 60 tuổi trở lên
Tiêm một liều đơn 0,5 mL.

Đối tượng trẻ em
Tính an toàn và hiệu quả của Abrysvo ở trẻ em (từ khi sinh ra đến dưới 18 tuổi) chưa được thiết lập. Dữ liệu ở trẻ vị thành niên mang thai và con của họ còn hạn chế (xem mục 13).

Cách dùng

Abrysvo được dùng để tiêm bắp vào vùng cơ delta ở phần trên của cánh tay.

Không được trộn vắc xin này với bất kỳ loại vắc xin hoặc dược phẩm nào khác.

Để biết hướng dẫn cách hoàn nguyên và xử lý trước khi dùng, xem mục 19.

6. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần tá dược nào liệt kê ở mục 2.

7. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Quá mẫn và phản vệ

Luôn cần phải chuẩn bị sẵn sàng phương pháp điều trị nội khoa và giám sát thích hợp trong trường hợp xảy ra biến cố phản vệ sau khi tiêm vắc xin.

Các phản ứng liên quan đến lo âu

Các phản ứng liên quan đến lo âu, bao gồm phản ứng do phản xạ thần kinh phế vị (ngất), tăng thông khí hoặc phản ứng liên quan đến căng thẳng có thể xảy ra liên quan đến việc tiêm vắc xin như là một đáp ứng do căn nguyên tâm lý với việc chọc kim tiêm. Điều quan trọng là phải thực hiện các quy trình để tránh bị thương do ngất xỉu.

Bệnh đồng mắc

Nên hoãn tiêm vắc xin ở người đang bị bệnh cấp tính có sốt. Tuy nhiên, không cần hoãn tiêm vắc xin nếu bị nhiễm trùng nhẹ, chẳng hạn như cảm lạnh.

Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu

Cần thận trọng khi dùng Abrysvo cho những người bị giảm tiểu cầu hoặc bất kỳ rối loạn đông máu nào vì có thể xảy ra chảy máu hoặc bầm tím sau khi tiêm bắp cho những người này.

Người bị suy giảm miễn dịch

Tính hiệu quả và an toàn của vắc xin chưa được đánh giá ở những người bị suy giảm miễn dịch, bao gồm những người đang dùng liệu pháp ức chế miễn dịch. Hiệu quả của Abrysvo có thể thấp hơn ở những người đang dùng liệu pháp ức chế miễn dịch.

Phụ nữ mang thai dưới 24 tuần

Abrysvo chưa được nghiên cứu ở những phụ nữ mang thai dưới 24 tuần. Vì tác dụng bảo vệ trẻ nhũ nhi chống lại RSV phụ thuộc vào sự vận chuyển kháng thể của người mẹ qua nhau thai, nên tiêm Abrysvo trong thời gian từ tuần 24 đến tuần 36 của thai kỳ (xem các mục 5 và 13).

Các giới hạn của hiệu quả của vắc xin

Như với bất kỳ vắc xin nào, đáp ứng miễn dịch bảo vệ có thể không được sinh ra sau khi tiêm vắc xin.

Tá dược

Sản phẩm này có chứa dưới 1 mmol natri (23 mg) mỗi liều, tức là về cơ bản "không chứa natri".

8. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thai kỳ

Dữ liệu ở phụ nữ mang thai (với hơn 4.000 kết quả) cho thấy vắc xin không gây dị tật cũng không có độc tính trên thai nhi/trẻ sơ sinh.

Kết quả từ các nghiên cứu trên động vật với Abrysvo không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính đối với chức năng sinh sản (xem mục 15).

Trong một nghiên cứu pha 3 (Nghiên cứu 1), các biến cố bất lợi ở người mẹ được báo cáo trong vòng 1 tháng sau khi tiêm vắc xin ở nhóm tiêm Abrysvo (14%) và nhóm tiêm giả dược (13%) tương tự nhau.

Không có dấu hiệu nào liên quan đến tính an toàn được phát hiện ở trẻ nhũ nhi cho đến 24 tháng tuổi. Tỷ lệ mắc các biến cố bất lợi được báo cáo trong vòng 1 tháng sau sinh ở trẻ nhũ nhi ở nhóm tiêm Abrysvo (37%) và nhóm tiêm giả dược (35%) tương tự nhau. Những biến cố chính được đánh giá trong nhóm tiêm Abrysvo so với giả dược bao gồm sinh non (lần lượt là 201 (6%) trường hợp và 169 (5%) trường hợp), nhẹ cân lúc sinh (lần lượt là 181 (5%) trường hợp và 155 (4%) trường hợp) và dị tật bẩm sinh (lần lượt là 174 (5%) trường hợp và 203 (6%) trường hợp).

Cho con bú

Không rõ liệu Abrysvo có tiết vào sữa mẹ hay không. Chưa thấy tác dụng bất lợi nào của Abrysvo ở trẻ sơ sinh bú sữa của người mẹ đã được tiêm vắc xin.

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu ở người về ảnh hưởng của Abrysvo lên khả năng sinh sản.

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khả năng sinh sản ở những cá thể cái (xem mục 15).

9. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Abrysvo không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc.

10. TƯƠNG TÁC VÀ TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Abrysvo có thể được tiêm đồng thời với vắc xin cúm mùa (Vắc xin cúm mùa tứ giá [Quadrivalent Influenza Vaccine – QIV]; kháng nguyên bề mặt, bất hoạt, có chất bổ trợ). Trong một nghiên cứu chọn ngẫu nhiên ở người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên, các tiêu chí về tính không thua kém của đáp ứng miễn dịch trong nhóm dùng đồng thời so với nhóm dùng riêng lẻ đã được đáp ứng. Tuy nhiên, đã quan sát thấy hiệu giá kháng thể trung hòa RSV A và B thấp hơn về số lượng và hiệu giá kháng thể ức chế ngưng kết hồng cầu cúm A và B thấp hơn về số lượng khi tiêm đồng thời Abrysvo và vắc xin cúm mùa bất hoạt có chất bổ trợ so với khi tiêm riêng rẽ. Không rõ mối liên quan lâm sàng của phát hiện này.

Nên có khoảng cách tối thiểu là hai tuần giữa thời điểm tiêm Abrysvo và thời điểm tiêm vắc xin uốn ván, bạch hầu và ho gà vô bào (Tdap). Không có mối lo ngại nào về độ an toàn khi tiêm đồng thời Abrysvo với Tdap ở phụ nữ khỏe mạnh không mang thai. Đáp ứng miễn dịch với RSV A, RSV B, bạch hầu và uốn ván khi tiêm đồng thời là không thua kém với đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm riêng rẽ. Tuy nhiên, đáp ứng miễn dịch với các thành phần ho gà thấp hơn khi tiêm đồng thời so với tiêm riêng rẽ và không đáp ứng các tiêu chí về tính không thua kém. Không rõ mối liên quan lâm sàng của phát hiện này.

Tương kỵ

Vì không có nghiên cứu về tính tương kỵ, không được trộn lẫn sản phẩm này với các dược phẩm khác.

11. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Tóm tắt hồ sơ an toàn

Phụ nữ mang thai
Ở phụ nữ mang thai trong 24-36 tuần của thai kỳ, các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất là đau tại vị trí tiêm vắc xin (41%), đau đầu (31%) và đau cơ (27%). Phần lớn các phản ứng cục bộ hoặc phản ứng toàn thân ở những phụ nữ mang thai tham gia đều có mức độ từ nhẹ đến vừa và hết trong vòng 2-3 ngày kể từ khi khởi phát.

Những người từ 60 tuổi trở lên
Ở những người từ 60 tuổi trở lên, các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất là đau tại vị trí tiêm vắc xin (11%). Phần lớn các phản ứng đều có mức độ từ nhẹ đến vừa và hết trong vòng 1-2 ngày kể từ khi khởi phát.

Bảng danh sách các phản ứng bất lợi

Độ an toàn của việc tiêm một liều đơn Abrysvo cho phụ nữ mang thai trong 24-36 tuần của thai kỳ (n=3.682) và cho những người từ 60 tuổi trở lên (n=18.575) đã được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng pha 3.

Các phản ứng bất lợi được liệt kê theo các phân loại tần suất sau:
Rất thường gặp (≥1/10);
Thường gặp (≥1/100 đến <1/10);
Ít gặp (≥1/1.000 đến <1/100)
Hiếm gặp (≥1/10.000 đến <1/1.000);
Rất hiếm gặp (<1/10.000);
Không rõ (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).

Các phản ứng bất lợi được báo cáo được liệt kê theo phân loại hệ cơ quan bị ảnh hưởng theo thứ tự mức độ nghiêm trọng giảm dần.

Bảng 1 Các phản ứng bất lợi sau khi tiêm Abrysvo

Phân loại hệ cơ quan	**Phản ứng bất lợi của thuốc đối với phụ nữ mang thai ≤49 tuổi**	**Phản ứng bất lợi của thuốc đối với những người ≥60 tuổi**
Rối loạn hệ miễn dịch		
Quá mẫn		Rất hiếm gặp
Rối loạn hệ thần kinh		
Đau đầu	Rất thường gặp	
Hội chứng Guillain-Barré		Hiếm gặp[a]
Rối loạn cơ xương và mô liên kết		
Đau cơ	Rất thường gặp	
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại vị trí tiêm		
Đau tại vị trí tiêm vắc xin	Rất thường gặp	Rất thường gặp
Đỏ tại vị trí tiêm vắc xin	Thường gặp	Thường gặp
Sưng tại vị trí tiêm vắc xin	Thường gặp	Thường gặp

[a] Trong một nghiên cứu ở những người từ 60 tuổi trở lên, một trường hợp mắc hội chứng Guillain-Barré và một trường hợp mắc hội chứng Miller Fisher đã được báo cáo với thời gian khởi phát lần lượt là 7 ngày và 8 ngày sau khi tiêm Abrysvo và được nghiên cứu viên đánh giá là có thể liên quan đến vắc xin được tiêm. Cả hai trường hợp này đều có các yếu tố nhiễu hoặc một nguyên nhân bệnh lý khác. Một trường hợp nữa, với thời gian khởi phát là 8 tháng sau khi tiêm Abrysvo, đã được nghiên cứu viên đánh giá là không liên quan đến vắc xin được tiêm. Một trường hợp mắc hội chứng Guillain-Barré đã được báo cáo trong nhóm tiêm giả dược 14 tháng sau thời điểm tiêm.

12. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Việc dùng quá liều Abrysvo không có khả năng xảy ra do vắc xin này được đóng gói ở dạng liều đơn.

Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho trường hợp quá liều Abrysvo. Trong trường hợp dùng quá liều, cần theo dõi người đã được tiêm quá liều và điều trị triệu chứng thích hợp.

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Vắc xin, vắc xin kháng vi rút khác, mã ATC: J07BX05

Cơ chế tác dụng

Abrysvo có chứa hai kháng nguyên F ổn định tái tổ hợp ở dạng tiền dung hợp của RSV đại diện cho các phân nhóm RSV-A và RSV-B. F tiền dung hợp là mục tiêu chính của các kháng thể trung hòa ngăn chặn nhiễm RSV. Sau khi tiêm bắp, kháng nguyên F tiền dung hợp sinh ra đáp ứng miễn dịch, bảo vệ chống lại bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV.

Ở trẻ nhũ nhi được sinh ra bởi người mẹ đã được tiêm Abrysvo trong khoảng 24 đến 36 tuần của thai kỳ, khả năng bảo vệ chống lại bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV có được là do truyền kháng thể trung hòa RSV qua nhau thai. Người trưởng thành từ 60 tuổi trở lên được bảo vệ bằng cách tiêm chủng chủ động.

Hiệu quả lâm sàng

Trẻ nhũ nhi từ khi sinh đến 6 tháng tuổi, bằng cách tiêm chủng chủ động cho người mẹ mang thai

Nghiên cứu 1 là một nghiên cứu pha 3, đa trung tâm, chọn ngẫu nhiên (1:1), mù đôi, có đối chứng giả dược để đánh giá tính hiệu quả của một liều đơn Abrysvo trong việc phòng ngừa bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV ở trẻ nhũ nhi được sinh ra bởi người mẹ mang thai được tiêm vắc xin trong khoảng thời gian từ Tuần 24 đến Tuần 36 của thai kỳ. Mức độ cần thiết của việc tiêm vắc xin nhắc lại ở những lần mang thai tiếp theo chưa được thiết lập.

Bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV được định nghĩa là một lần khámcó chẩn đoán bệnh RSV xác nhận bằng phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược (reverse transcription-polymerase chain reaction - RT-PCR) kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng hô hấp sau đây: thở nhanh, độ bão hòa oxy thấp (SpO_2 <95%) và rút lõm lồng ngực. Bệnh đường hô hấp dưới nặng liên quan đến RSV được định nghĩa là bệnh đáp ứng các tiêu chí của bệnh đường hô hấp dưới do RSV kết hợp với ít nhất một trong những triệu chứng sau: thở rất nhanh, độ bão hòa oxy thấp (SpO_2 <93%), bổ sung oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi hoặc thở máy, nhập viện vào khoa hồi sức tích cực (intensive care unit - ICU) trong >4 giờ và/hoặc không phản ứng/bất tỉnh.

Trong nghiên cứu này, 3.695 phụ nữ đang mang thai đơn, không có biến chứng đã được chọn ngẫu nhiên vào nhóm tiêm Abrysvo và 3.697 người vào nhóm tiêm giả dược.

Hiệu quả của vắc xin (vaccine efficacy - VE) được định nghĩa là giảm nguy cơ tương đối của tiêu chí đánh giá trong nhóm tiêm Abrysvo so với nhóm tiêm giả dược đối với trẻ nhũ nhi được sinh ra bởi người mẹ đã tiêm vắc xin can thiệp theo chỉ định trong thai kỳ. Có hai tiêu chí đánh giá hiệu quả chính, được đánh giá song song, là bệnh đường hô hấp dưới nặng dương tính với RSV cần chăm sóc y tế và bệnh đường hô hấp dưới cần chăm sóc y tế dương tính với RSV, xảy ra trong vòng 90, 120, 150 hoặc 180 ngày sau sinh.

Trong số những phụ nữ mang thai được tiêm Abrysvo, 65% là người Da trắng, 20% là người Da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và 29% là người gốc Tây Ban Nha/Latino. Tuổi trung vị là 29 tuổi (trong khoảng từ 16-45 tuổi); 0,2% số người tham gia dưới 18 tuổi và 4,3% số người tham gia dưới 20 tuổi. Tuổi thai trung vị tại thời điểm tiêm vắc xin là 31 tuần 2 ngày (trong khoảng từ 24 tuần 0 ngày đến 36 tuần 4 ngày). Tuổi thai trung vị của trẻ nhũ nhi lúc sinh là 39 tuần 1 ngày (trong khoảng từ 27 tuần 3 ngày đến 43 tuần 6 ngày).

Hiệu quả của vắc xin được trình bày trong các Bảng 2 và 3.

Bảng 2 Hiệu quả của vắc xin Abrysvo chống lại bệnh đường hô hấp dưới nặng cần chăm sóc y tế do RSV gây ra ở trẻ nhũ nhi từ khi sinh ra đến 6 tháng tuổi bằng cách tiêm chủng chủ động cho người mẹ lúc mang thai – Nghiên cứu 1

Khoảng thời gian	Abrysvo Số trường hợp N=3.495	Giả dược Số trường hợp N=3.480	VE % (CI)[a]
90 ngày	6	33	81,8 (40,6; 96,3)
120 ngày	12	46	73,9 (45,6; 88,8)
150 ngày	16	55	70,9 (44,5; 85,9)
180 ngày	19	62	69,4 (44,3; 84,1)

CI = khoảng tin cậy; VE = hiệu quả của vắc xin

[a] CI 99,5% tại thời điểm 90 ngày; CI 97,58% ở các khoảng thời gian sau đó

Bảng 3 Hiệu quả của vắc xin Abrysvo chống lại bệnh đường hô hấp dưới cần chăm sóc y tế do RSV gây ra ở trẻ nhũ nhi từ khi sinh ra đến 6 tháng tuổi bằng cách tiêm chủng chủ động cho người mẹ lúc mang thai – Nghiên cứu 1

Khoảng thời gian	Abrysvo Số trường hợp N=3.495	Giả dược Số trường hợp N=3.480	VE % (CI)[a]
90 ngày	24	56	57,1 (14,7; 79,8)

Khoảng thời gian	**Abrysvo Số trường hợp N=3.495**	**Giả dược Số trường hợp N=3.480**	**VE % (CI)[a]**
120 ngày	35	81	56,8 (31,2; 73,5)
150 ngày	47	99	52,5 (28,7; 68,9)
180 ngày	57	117	51,3 (29,4; 66,8)

CI = khoảng tin cậy; VE = hiệu quả của vắc xin

[a] CI 99,5% tại thời điểm 90 ngày; CI 97,58% ở các khoảng thời gian sau đó

Một phân tích hậu định về VE theo tuổi thai của người mẹ đã được thực hiện. Đối với bệnh đường hô hấp dưới nặng cần chăm sóc y tế xảy ra trong vòng 180 ngày, VE là 57,2% (CI 95% là 10,4; 80,9) đối với phụ nữ được tiêm vắc xin sớm trong thai kỳ (24 tuần đến <30 tuần) và 78,1% (CI 95% là 52,1; 91,2) đối với phụ nữ được tiêm vắc xin muộn hơn trong khoảng thời gian đủ điều kiện của thai kỳ (30 tuần đến 36 tuần). Đối với bệnh đường hô hấp dưới cần chăm sóc y tế trong vòng 180 ngày, VE là 30,9% (CI 95% là -14,4; 58,9) đối với phụ nữ được tiêm vắc xin sớm trong thai kỳ (24 tuần đến <30 tuần) và 62,4% (CI 95% là 41,6; 76,4) đối với phụ nữ được tiêm vắc xin muộn hơn trong khoảng thời gian đủ điều kiện của thai kỳ (30 tuần đến 36 tuần).

Tiêm chủng chủ động cho những người từ 60 tuổi trở lên

Nghiên cứu 2 là một nghiên cứu pha 3, đa trung tâm, chọn ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược để đánh giá tính hiệu quả của Abrysvo trong việc phòng ngừa bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV ở những người từ 60 tuổi trở lên.

Bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV được định nghĩa là bệnh do RSV có chẩn đoán xác định bằng RT-PCR có từ hai hoặc ba triệu chứng hô hấp sau đây trở lên trong vòng 7 ngày khởi phát triệu chứng và kéo dài hơn 1 ngày trong cùng một bệnh: ho mới xảy ra hoặc tăng lên, thở khò khè, tiết đờm, thở dốc hoặc thở nhanh (≥25 nhịp thở/phút hoặc tăng 15% so với mức ban đầu khi nghỉ ngơi).

Những người tham gia đã được chọn ngẫu nhiên (1:1) để được tiêm Abrysvo (n=18.488) hoặc giả dược (n=18.479). Việc thu nhận được phân tầng theo độ tuổi 60-69 tuổi (63%), 70-79 tuổi (32%) và ≥80 tuổi (5%). Các đối tượng có các bệnh nền mạn tính ổn định đủ điều kiện tham gia nghiên cứu này và 52% số người tham gia có ít nhất 1 tình trạng đã xác định trước; 16% số người tham gia được thu nhận có các bệnh tim phổi mạn tính ổn định như hen suyễn (9%), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (7%) hoặc suy tim sung huyết (2%). Những người bị suy giảm miễn dịch không đủ điều kiện tham gia.

Mục tiêu chính là đánh giá hiệu quả của vắc xin (VE), được định nghĩa là giảm nguy cơ tương đối xảy ra đợt đầu tiên của bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV trong nhóm tiêm Abrysvo so với nhóm tiêm giả dược trong mùa RSV đầu tiên.

Trong số những người tham gia được tiêm Abrysvo, 51% là nam giới và 80% là người Da trắng, 12% là người Da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và 41% là người gốc Tây Ban Nha/Latino. Tuổi trung vị của người tham gia là 67 tuổi (trong khoảng từ 59-95 tuổi).

Khi kết thúc mùa RSV đầu tiên, phân tích đã cho thấy hiệu quả có ý nghĩa thống kê của Abrysvo trong việc giảm bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV với ≥2 triệu chứng và với ≥3 triệu chứng.

Thông tin về hiệu quả của vắc xin được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4 Hiệu quả của vắc xin Abrysvo chống lại bệnh RSV - tiêm chủng chủ động cho những người từ 60 tuổi trở lên – Nghiên cứu 2

Tiêu chí đánh giá hiệu quả	Abrysvo Số trường hợp N=18.058	Giả dược Số trường hợp N=18.076	VE (%) (CI 95%)
Đợt đầu tiên của bệnh đường hô hấp dưới có liên quan đến RSV với ≥2 triệu chứng[a]	15	43	65,1 (35,9; 82,0)
Đợt đầu tiên của bệnh đường hô hấp dưới có liên quan đến RSV với ≥3 triệu chứng[a]	2	18	88,9 (53,6; 98,7)

CI – khoảng tin cậy; RSV – vi rút hợp bào hô hấp; VE – hiệu quả của vắc xin

[a] Trong một phân tích thăm dò ở RSV phân nhóm A (Abrysvo n=3, giả dược n=16 VE là 81,3% (CI 34,5; 96,5); và ở RSV phân nhóm B (Abrysvo n=12, giả dược n=26) VE là 53,8% (CI 5,2; 78,8).

[b] Trong một phân tích thăm dò ở RSV phân nhóm A (Abrysvo n=1, giả dược n=5), VE là 80,0% (CI -78,7; 99,6); và ở RSV phân nhóm B (Abrysvo n=1, giả dược n=12), VE là 91,7% (CI 43,7; 99,8).

14. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

15. DỮ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG

Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có nguy cơ đặc biệt nào đối với con người dựa trên các nghiên cứu thông thường về độc tính liều lặp lại và độc tính đối với khả năng sinh sản và phát triển.

16. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp chứa 1 lọ bột thuốc, 1 bơm tiêm đóng sẵn dung môi, 1 đầu nối lọ với 1 kim tiêm (1 liều).
Hộp chứa 5 lọ bột thuốc, 5 bơm tiêm đóng sẵn dung môi, 5 đầu nối lọ với 5 kim tiêm (5 liều).
Hộp chứa 10 lọ bột thuốc, 10 bơm tiêm đóng sẵn dung môi, 10 đầu nối lọ với 10 kim tiêm (10 liều).

17. HẠN DÙNG

36 tháng.

Lọ chưa mở ổn định trong 5 ngày khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 8°C đến 30°C. Khi hết thời gian này, Abrysvo phải được sử dụng hoặc thải bỏ. Thông tin này được dùng để hướng dẫn nhân viên y tế chỉ trong trường hợp chênh lệch nhiệt độ tạm thời.

Sau khi hoàn nguyên

Nên tiêm Abrysvo ngay sau khi hoàn nguyên hoặc trong vòng 4 giờ nếu bảo quản ở nhiệt độ từ 15°C đến 30°C. Không để đóng băng.

Độ ổn định hóa học và vật lý trong quá trình sử dụng đã được chứng minh là trong 4 giờ ở nhiệt độ từ 15°C đến 30°C. Từ quan điểm vi sinh, nên sử dụng sản phẩm này ngay lập tức. Nếu không dùng ngay lập tức, người dùng chịu trách nhiệm về thời gian và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng.

18. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C - 8°C).

Không để đóng băng. Thải bỏ nếu hộp giấy đã bị đóng băng.

Để biết điều kiện bảo quản sau khi hoàn nguyên thuốc, xem mục 17.

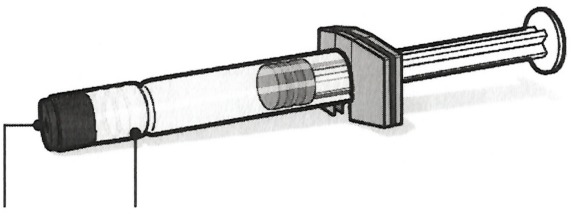
19. LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ XỬ LÝ THUỐC TRƯỚC VÀ SAU KHI SỬ DỤNG

Abrysvo phải được hoàn nguyên trước khi tiêm bằng cách thêm toàn bộ dung môi chứa trong bơm tiêm đóng sẵn vào lọ chứa bột bằng cách sử dụng đầu nối lọ.

Chỉ được phép hoàn nguyên vắc xin bằng dung môi đi kèm.

Chuẩn bị để tiêm

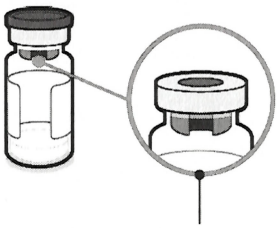
Bơm tiêm đóng sẵn chứa dung môi cho Abrysvo



Nắp bơm tiêm

Đốc khóa Luer

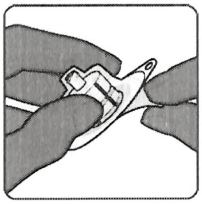
Lọ chứa kháng nguyên cho Abrysvo (bột)



Nút bít lọ (đã gỡ nắp lật)

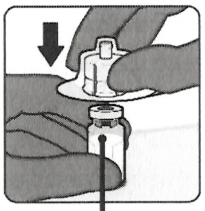
Đầu nối lọ

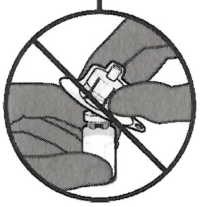




Bước 1. Chuẩn bị đầu nối lọ

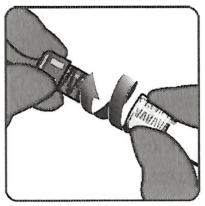
- Gỡ nắp lật bằng nhựa ra khỏi lọ và lau nút bít cao su.
- Mở bao bì chứa đầu nối lọ bằng cách bóc lớp phủ trên cùng ra.
- Không lấy đầu nối lọ ra khỏi bao bì.





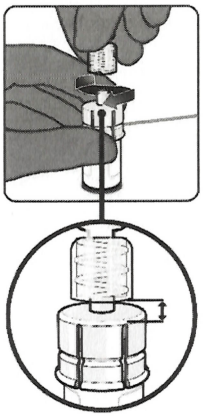
Bước 2. Lắp đầu nối lọ vào lọ chứa kháng nguyên của Abrysvo

- Giữ đáy lọ trên một bề mặt bằng phẳng.
- Để đầu nối lọ trong bao bì và đặt đầu nối thẳng đứng trên tâm của lọ sao cho mũi nhọn của đầu nối thẳng với tâm của nút bít cao su của lọ.
- Nối đầu nối lọ với lọ bằng cách đẩy thẳng xuống. Đầu nối lọ sẽ khóa vào đúng chỗ.
- Không đẩy đầu nối lọ vào theo góc nghiêng vì việc này sẽ dẫn đến rò rỉ thuốc trong quá trình sử dụng.
- Gỡ bao bì đầu nối lọ.



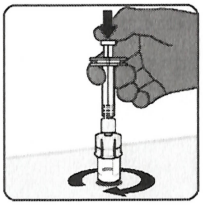
Bước 3. Tháo nắp bơm tiêm

- Đối với tất cả các bước lắp ráp bơm tiêm, chỉ cầm bơm tiêm ở đốc khóa Luer nằm ở phần đầu bơm tiêm. Việc ngày sẽ ngăn không cho đốc khóa Luer bị long ra trong quá trình sử dụng.
- Tháo nắp bơm tiêm bằng cách xoay nắp từ từ ngược chiều kim đồng hồ trong khi giữ đốc khóa Luer.



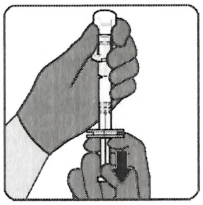
Bước 4. Nối bơm tiêm với đầu nối lọ

- Giữ đốc khóa Luer của bơm tiêm và nối nó với đầu nối lọ bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.
- Ngừng vặn khi cảm thấy lực cản, vặn quá chặt bơm tiêm có thể dẫn đến rò rỉ thuốc trong quá trình sử dụng.
- Khi bơm tiêm đã được lắp chắc chắn vào đầu nối lọ, sẽ có một khoảng hở nhỏ giữa phần trên cùng của đầu nối lọ và đốc khóa Luer của bơm tiêm.



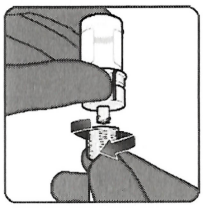
Bước 5. Bơm dung môi và xoáy nhẹ nhàng

- Bơm toàn bộ dung môi trong bơm tiêm vào lọ.
- Không tháo bơm tiêm rỗng ra.
- Trong khi giữ cần pít tông ở vị trí bị ấn xuống, nhẹ nhàng xoáy lọ theo chuyển động tròn cho đến khi hòa tan bột thuốc hoàn toàn (khoảng 1-2 phút).
- Không được lắc.



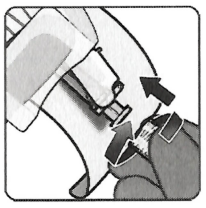
Bước 6. Rút phần thuốc trong lọ

- Đảo ngược lọ hoàn toàn với đầu nối lọ và bơm tiêm vẫn được lắp vào.
- Từ từ rút toàn bộ phần thuốc trong lọ vào bơm tiêm.
- Rút tất cả phần thuốc trong lọ có thể lấy được đảm bảo đủ liều 0,5 mL để tiêm.
- Không kéo cần pít tông ra.



Bước 7. Tháo bơm tiêm

- Giữ đốc khóa Luer của bơm tiêm và tháo bơm tiêm khỏi đầu nối lọ bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ.



Bước 8. Lắp kim tiêm

- Lắp kim tiêm vô trùng phù hợp để tiêm bắp vào bơm tiêm đóng sẵn thuốc bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.
- Không vặn quá chặt kim tiêm vì việc này có thể dẫn đến rò rỉ thuốc trong quá trình sử dụng.

Bước 9. Kiểm tra trực quan

- Vắc xin đã chuẩn bị là dung dịch trong và không màu.
- Kiểm tra trực quan vắc xin xem có hạt lớn và đổi màu không trước khi tiêm. Không sử dụng nếu thấy có hạt lớn hoặc đổi màu.

Thải bỏ

Cần phải thải bỏ hết thuốc không sử dụng hoặc vật liệu phế thải theo các yêu cầu của địa phương.

20. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở.

21. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12, 2870 Puurs-Sint-Amands, Bỉ

® Nhãn hiệu đã đăng ký

Nếu bạn có câu hỏi y khoa về các sản phẩm dược phẩm của Pfizer Việt Nam, vui lòng truy cập trang web www.pfizermedicalinformation.vn của Bộ phận Thông tin Y khoa Pfizer, hoặc gửi qua trang web https://pmiform.com/HCP/VN-V.

LPD date: 19 Sep 2024
Reference EU CP SPC effective date: 23 Aug 2023